Chequeo de Salud
Informe médico

HOSPITAL SANITAS CIMA

Sanitas
Parte de Bupa

Chequeo de Salud
Informe médico

Nos complace que hayas tomado la decisión de cuidar tu salud y dedicar tiempo a realizarte un chequeo médico en nuestro centro. La medicina preventiva es una herramienta invaluable para mantener tu bienestar, y un chequeo completo puede proporcionarte información importante sobre el estado de tu organismo.

En nuestro centro, nos enfocamos en ofrecerte un chequeo exhaustivo y personalizado que se adapte a tus necesidades. Entendemos que cada individuo es único, y por eso nos centramos en el estudio detallado de diversos sistemas, dependiendo del tipo de chequeo que elijas.

El objetivo principal de un chequeo médico es detectar cualquier anomalía o signo temprano de enfermedad, incluso antes de que aparezcan síntomas evidentes. Esto nos permite intervenir rápidamente y tomar las medidas necesarias para prevenir o tratar cualquier problema de salud.

Durante el chequeo, nuestros profesionales altamente capacitados realizarán una serie de pruebas y evaluaciones para evaluar tu estado de salud general. Esto incluirá valoración por distintos especialistas y analítica sanguínea que junto a otras pruebas complementarias, cuyos resultados serán finalmente valorados por un especialista en Medicina Interna, que elaborará una serie de recomendaciones en función de cada caso (tratamientos médicos o realización de otras pruebas más específicas).

Recuerda que la información recopilada durante el chequeo se mantiene confidencial y se utiliza únicamente con el propósito de evaluar y mejorar tu salud. Estamos comprometidos con ofrecerte los mejores cuidados y orientación médica en cada etapa de tu vida.

FECHA CHEQUEO MÉDICO: 21/03/2025

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE: MARIUSZ JAROSLAW GRALEWSKI .

EMAIL DE CONTACTO*: mariusz.gralewski@gmail.com

TELÉFONO DE CONTACTO*: 681656090

*Datos de contacto que usaremos desde la Unidad de Chequeos Médicos de Sanitas Hospitales para recordarles las fechas para los próximos reconocimientos médicos.

Antecedentes:

Alergias:

No alergias conocidas

Medicación habitual:

Estatina

Hábitos:

No fumador

Ejercicio físico habitual con buena tolerancia

Otros antecedentes personales y familiares:

Antecedentes personales: Hipercolesterolemia

No intervenciones quirúrgicas

Antecedentes familiares:
Abuelo: Infarto agudo de miocardio
Abuela: Cáncer de mama

Exploración física:

Cabeza y cuello:

ECO DOPPLER DE TRONCOS SUPRAAÓRTICOS:
Practicados múltiples cortes multidireccionales con sonda de alta frecuencia.
Territorio derecho.
Arterias carótida común, interna, externa y vertebral de aspecto normal, permeables y con ondas espectrales dentro de la normalidad. Índice CI/CC < 2.
No se evidencian placas de ateroma a nivel del inicio de la carótida interna que produzca estenosis significativas.
Arteria vertebral permeable con flujo anterógrado.
Grosor intimal de 0, 4 mm.
Territorio izquierdo.
Arterias carótida común, interna, externa y vertebral de aspecto normal, permeables y con ondas espectrales dentro de la normalidad. Índice CI/CC < 2.
No se evidencian placas de ateroma a nivel del inicio de la carótida interna que produzca estenosis significativas.
Arteria vertebral permeable con flujo anterógrado.
Grosor intimal de 0, 5 mm.
Arterias subclavias permeables con flujo trifásico
Conclusión: Estudio de TSA sin alteraciones significativas.

Tórax:

Auscultación cardíaca rítmica

Auscultación pulmonar normal

Abdomen:

Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, peristaltismo presente. No signos de irritación peritoneal. No palpo masas ni megalias

Puñopercusión renal negativa

Extremidades:

No edemas

Pulsos distales presentes

Exploración neurológica:

Consciente y orientado
Pupilas isocóricas y reactivas
Pares craneales normales
Fuerza y sensibilidad conservadas
Romberg negativo

Tensión arterial y pulso:

Tensión arterial 110/55

Frecuencia cardíaca 83 latidos por minuto

Recomendaciones:

1. Alimentación equilibrada: Una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras y grasas saludables. Evita los alimentos procesados, ricos en azúcares añadidos y grasas saturadas.

2. Actividad física regular: Realiza ejercicio físico de forma regular. Realiza al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad vigorosa por semana, además de ejercicios de fuerza muscular al menos dos veces por semana.

3. La importancia de un sueño reparador: Con una duración de 7 a 9 horas de sueño por noche para adultos.

4. Se recomienda control anual con urología y PSA

5. Revisiones anuales

6. Controles periodicos con colonoscopia dependientedo del resultado de la anatomía patológica

Conclusiones del chequeo:

Hemorroides internas

Polipo en sigma (ANATOMÍA PATOLÓGICA PENDIENTE)

Revisión de Masa Corporal

¿QUÉ ES LA OBESIDAD?

La obesidad es una enfermedad crónica y compleja caracterizada por un exceso de acumulación de grasa en el cuerpo. Se considera una condición médica en la cual el índice de masa corporal (IMC), que es una medida que relaciona el peso y la estatura de una persona, es igual o mayor a 30.

La obesidad puede ser el resultado de una combinación de factores genéticos, ambientales, metabólicos y de estilo de vida. El consumo excesivo de calorías, especialmente provenientes de alimentos ricos en grasas y azúcares, junto con la falta de actividad física, son factores comunes que contribuyen al desarrollo de la obesidad.

La obesidad puede tener numerosas consecuencias negativas para la salud Las personas con obesidad tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, enfermedades del hígado, trastornos del sueño, ciertos tipos de cáncer y problemas musculoesqueléticos, entre otros.

Además de los riesgos para la salud física, la obesidad también puede tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de una persona Puede afectar la autoestima, provocar depresión, ansiedad y dificultades en las relaciones sociales.

Tabla 1: Clasificación del IMC según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad

Índice de masa corporal varones	Índice de masa corporal mujeres	Interpretación de índice de masa corporal
MENOR 20	MENOR 20	**BAJO PESO**
20 - 24,9	20 - 23,9	**NORMAL**
25 - 29,9	24 - 28,9	**OBESIDAD LEVE**
30 - 40	29 - 37	**OBESIDAD SEVERA**
MAYOR 40	MAYOR 37	**OBESIDAD MUY SEVERA**

Índice de Masa Corporal:

24.54

Talla y Peso:

Talla 180 cm

Peso 79.5

Análisis clínicos:

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS ANÁLISIS CLÍNICOS?

La prueba de los análisis clínicos de orina y sangre son herramientas fundamentales en el campo de la medicina para evaluar la salud y diagnosticar enfermedades. A continuación, te explico brevemente en qué consisten ambas pruebas:

Análisis clínicos de orina:

- Recolección de la muestra: Se solicita al paciente que proporcione una muestra de orina en un recipiente estéril. Por lo general, se recoge una muestra de la primera micción de la mañana para obtener resultados más precisos.

- Examen macroscópico: Se realiza una inspección visual de la muestra para detectar características anormales, como la presencia de sangre, turbidez o cambio de color.

- Examen químico: Se utilizan tiras reactivas que contienen sustancias químicas que reaccionan con diferentes componentes de la orina, como la presencia de proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno, entre otros.

- Examen microscópico: Se analiza una pequeña muestra de orina bajo el microscopio para identificar y contar células sanguíneas, células epiteliales, bacterias, cristales, cilindros y otros elementos que pueden indicar la presencia de enfermedades o infecciones en el sistema urinario.

Análisis clínicos de sangre:

- Extracción de la muestra: Se extrae una muestra de sangre del paciente generalmente de una vena en el brazo, utilizando una aguja estéril y un tubo de recolección.

- Hemograma completo: Se realiza un recuento y análisis de los diferentes componentes de la sangre, como los glóbulos rojos (hematíes), los glóbulos blancos (leucocitos) y las plaquetas. También se evalúan los índices hematológicos, como la hemoglobina y el hematocrito.

- Perfil bioquímico: Se evalúan los niveles de diferentes sustancias químicas y enzimas en la sangre, como los niveles de glucosa, lípidos (colesterol y triglicéridos), proteínas, electrolitos (sodio, potasio), enzimas hepáticas, función renal, entre otros. Estos análisis pueden proporcionar información sobre el estado general del organismo y ayudar a detectar enfermedades o trastornos específicos.

- Pruebas específicas: Dependiendo de los síntomas del paciente o las sospechas diagnósticas, se pueden realizar pruebas adicionales, como análisis de hormonas, marcadores tumorales, pruebas de coagulación, entre otros.

Informe de sus análisis clínicos:

Analítica de sangre: Sin alteraciones significativas

Analítica de orina: Sin alterciones signficativas

Pruebas de radiodiagnóstico
Ecografía abdominal y pélvica

¿En qué consiste la ecografía abdomino pélvica?

Permite evaluar los órganos sólidos abdominales incluyendo el hígado, páncreas, bazo, riñones y barrido prostático en hombres ,y aquellas vísceras huecas que estén rellenas de líquido, como la vesícula biliar y la vejiga.

Informe de su exploración:

Hígado de tamaño normal, de ecoestructura homogénea, sin dilatación del árbol biliar intrahepático. Contorno hepático regular. No se observan imágenes nodulares.
Vesícula biliar distendida, de paredes finas, sin cálculos.
VBP de calibre normal
Sistema porta permeable, de calibre normal con flujo hepatópeto.
AMS, eje venoso esplenomesenterico y venas suprahepáticas permeables.
Area pancreática sin alteraciones valorables.
Bazo de tamaño y morfología normal

Pruebas de radiodiagnóstico
Exploración Radiológica del Tórax

¿En qué consiste la revisión radiológica de tórax?

La radiografía simple permite evaluar la patología pulmonar, de la vía aérea baja, cardiaca y ósea del tórax. Permite una aproximación y despistaje de patologías cardiopulmonares y óseas.

Informe de su radiografía del tórax:

Parénquima pulmonar sin condensaciones agudas.
Senos costofrénicos libres.
Vértices bien ventilados.
Silueta cardiaca dentro de la normalidad.

Revisión Oftalmológica

¿En qué consiste la revisión oftalmológica?

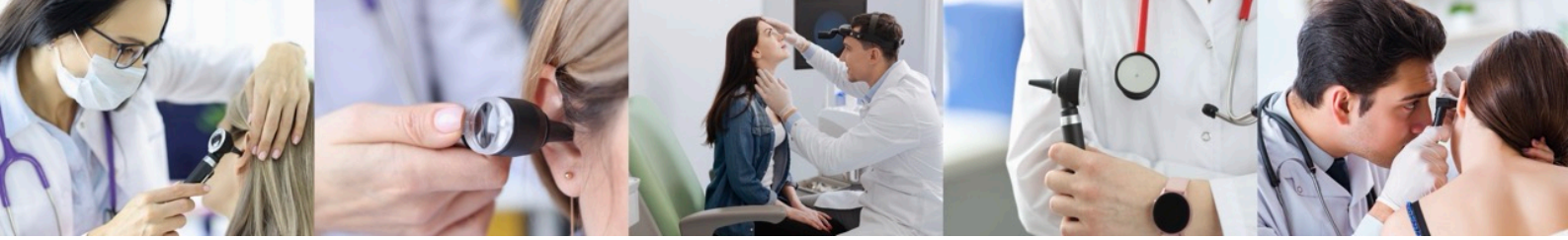
La revisión oftalmológica es un proceso que tiene como objetivo evaluar la salud visual y detectar posibles problemas o enfermedades oculares. Consiste en varias pruebas como:

- La agudeza visual: para evaluar la nitidez de la visión a diferentes distancias.
- El examen de refracción: que se realiza para determinar el grado de error refractivo del paciente, como la miopía, hipermetropía o astigmatismo.
- El examen de la estructura ocular: que permitirá detectar problemas como la degeneración macular, glaucoma, retinopatía diabética y otras enfermedades oculares a través de un examen del interior del ojo, incluyendo la retina, el nervio óptico y los vasos sanguíneos.
- La evaluación de la presión intraocular: que se mide la presión dentro del ojo mediante un tonómetro. La alta presión intraocular puede ser un indicador de glaucoma.

Juicio Clínico:

Exploración oftalmológica dentro de los límites de la normalidad en ambos ojos.

Recomendaciones: Revisiones periódicas



Revisión Otorrinolaringología

¿En qué consiste la revisión otorrinolaringología?

Se realizará un examen físico completo de la cabeza y el cuello para evaluar las estructuras como los oídos, la nariz, la faringe, los senos paranasales y los ganglios linfáticos. Y a continuación otras pruebas como:

- Audiometría: es una prueba de audición para evaluar la capacidad auditiva y detectar cualquier problema relacionado con los oídos y la audición.
- Fibroscopia: para examinar visualmente el interior de la nariz y la garganta, lo que permite al médico detectar cualquier anomalía, como pólipos nasales, tumores o inflamación.
- Otoscopia: para examinar el canal auditivo y el tímpano, en busca de signos de infecciones, perforaciones timpánicas u otros problemas relacionados con el oído medio.

Y en algunos casos, se pueden solicitar radiografías, tomografías computarizadas (TC) o resonancias magnéticas (RM) para obtener imágenes más detalladas de las estructuras de la cabeza y el cuello.

Informe de su exploración otorrinolaringóloga:

Fosas Nasales:
Fosas nasales permeables sin secreciones.

Faringe:
Faringe normal.

Otoscopia:
Tímpanos íntegros de aspecto normal.

Laringe:
Cuerdas vocales lisas y móviles.

Audiometría:
Normal

Juicio Clínico:
Chequeo dentro de la normalidad

Control anual

Revisión Cardiológica

VALORACIÓN DEL RIESGO CORONARIO

¿En qué consiste la valoración de riesgo coronario?

A lo largo de la vida, un paciente puede presentar uno o varios factores de riesgo cardiovascular que aumentan el riesgo de presentar cardiopatía isquémica. Si tratamos al paciente antes de que se manifieste la enfermedad coronaria, el pronóstico será mejor. En consecuencia, es necesario valorar el riesgo que tiene un sujeto de desarrollar eventos cardiovasculares, para poder prevenir en la medida de lo posible esta situación. Es lo que denominamos estratificación del riesgo coronario La valoración del riesgo coronario de un paciente debe comenzar por realizar una buena historia clínica. Una vez realizada, y según el riesgo individual, realizaremos una u otra prueba según los hallazgos encontrados.

- Presión arterial: El término “presión arterial” se refiere al nivel de “fuerza” o “presión” que existe en el interior de las arterias. Esta presión es producida por el flujo de sangre. Cada vez que late el corazón, sube la presión (presión sistólica). Y entre latidos, cuando el corazón está en reposo, esta presión vuelve a bajar (presión diastólica).La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes. La determinación de la presión arterial deben estar por debajo de 140/90 mmHg (130/80 mmHg en diabéticos y en pacientes con insuficiencia renal).

- Electrocardiograma basal: El electrocardiograma representa la actividad eléctrica de las células del corazón, y aporta información muy útil.Su uso principal consiste en el diagnóstico de las enfermedades cardiacas, como las enfermedades congénitas o el infarto. Así mismo, mediante el electrocardiograma valoraremos la presencia de hipertrofia ventricular, arritmias, entre otras alteraciones.

- Tablas de riesgo coronario: Las distintas Sociedades de Cardiología tanto europeas como americanas han desarrollado distintas tablas de valoración de riesgo. Una de las clasificaciones más utilizadas por su facilidad de uso es la propuesta por la NCEP-ATP III . Esta clasificación relaciona el número de factores de riesgo que tiene una persona con el riesgo de sufrir un evento coronario a 10 años. A mayor número de factores de riesgo, mayor riesgo.

- Ergonometría: Una vez realizada la valoración clínica del paciente, ya tendremos una primera aproximación del riesgo coronario que presenta el paciente. Sin embargo, existen distintas pruebas diagnósticas que nos van a ayudar para una mejor valoración del paciente. Una de las pruebas que más información nos va a aportar es la Ergometría, (también denominada Prueba de Esfuerzo físico o Electrocardiograma de esfuerzo), realizada ya sea en tapiz rodante o en bicicleta. Con esta prueba lo que se hace en esencia es someter al corazón a un nivel de trabajo elevado y valorar cómo se comportan distintos parámetros (electrocardiograma y presión arterial) con el esfuerzo.

- Ecocardiograma: Es un examen no invasivo que permite una visión del tamaño, forma y movimiento del corazón por medio de ultrasonidos. Aporta información, entre otras cosas, sobre la función contráctil del miocardio, si existen lesiones valvulares o la presencia de derrame pericárdico. Ante un paciente con sospecha de cardiopatía isquémica nos puede indicar si existen alteraciones en la contractilidad global y/o segmentaria del corazón.

Tabla de riesgo coronario:

Hábito Tabáquico	
Hipertensión Arterial	
Colesterol HDL < 40 mg/dl	
Historia familiar de enfermedad coronaria prematura (en familiares de primer grado <55 años si es varón y <65 años si es mujer)	
Edad (>45 años en el varón y >55 años en mujer)	
0-1 factores de riesgo	Bajo (<10%)
2 o más factores de riesgo	Hipertensión arterial
Enfermedad coronaria o riesgo equivalente	Medio (10-20%)
	Alto (>20%)

Informe de su exploración cardíaca:

Presión arterial y pulso:

Tensión arterial 110/55

Frecuencia cardíaca: 83 latidos por minuto

Ergometría:

No alteraciones isquémicas del ST a la frecuencia cardíaca alcanzada
Capacidad funcional buena para su edad y sexo
Respuesta tensional normal al esfuerzo
No arritmias

Test de esfuerzo clínico y electrocardiográficamente negativo para isquemia miocárdica

Ecocardiograma:

Ecocardiograma sin alteraciones significativas

Revisión Urológica

¿En qué consiste la revisión de urología?

La revisión urológica es un conjunto de evaluaciones médicas realizadas por un urólogo para examinar el sistema urinario y los órganos reproductores masculinos. Estas revisiones son importantes para detectar y tratar problemas urológicos en etapas tempranas, incluso antes de que aparezcan los síntomas. Durante una revisión urológica, el médico puede llevar a cabo varios procedimientos y pruebas, que pueden incluir:

- Entrevista y examen físico: El urólogo puede hacerle preguntas sobre su historial médico, síntomas actuales y estilo de vida. Luego, realizará un examen físico para evaluar los órganos genitales, la próstata y otras áreas relevantes.

- Análisis de orina: Se recoge una muestra de orina para analizarla en el laboratorio. Esto puede revelar signos de infección, presencia de sangre u otros problemas.

- Análisis de sangre: Se pueden realizar pruebas de sangre para evaluar la función renal, los niveles de PSA (antígeno prostático específico) y otros marcadores que ayudan a detectar enfermedades urológicas, como el cáncer de próstata.

- Ecografía: Se utiliza la ecografía para obtener imágenes del sistema urinario, incluyendo los riñones, la vejiga y la próstata. Esto puede ayudar a identificar cálculos renales, tumores u otras anomalías.

- Pruebas urodinámicas: Estas pruebas evalúan la función de la vejiga y el flujo urinario. Se utilizan para diagnosticar trastornos de la vejiga, como la incontinencia urinaria o la obstrucción del flujo urinario.

Anamnesis:

Paciente varón de 41 años de edad quien consulta para chequeo urológico anual.

Niega síntomas del tracto urinario inferior. Patrón miccional satisfactorio.

Antecedentes de prostatitis ahora asintomático

Antecedentes familiares: Tio materno con adenocarcinoma de próstata en familia

Informe de su exploración urológica:

Ecografía abdominal:

Riñón derecho de 11 x 4,4 cm. No hay ectasia del sistema excretor ni alteraciones morfológicas. Contorno renal regular. Situación renal correcta. Distancia córtico-papilar conservada. No se observan imágenes sugestivas de litiasis.
Riñón izquierdo de 12,8 x 5,1 cm. No hay ectasia del sistema excretor, con imagen nodular parcialmente cálcica , posible quiste del tipo II F de bosniak , de 13 mm. Contorno renal regular. Situación renal correcta. Distancia córtico-papilar conservada. No se observan imágenes sugestivas de litiasis.
Vejiga urinaria con un volumen pre-miccional de 421 cc., de paredes lisas, sin masas endocavitarias. Residuo post-miccional nulo.
Glándula prostática con un volumen de 22 cc. Patrón ecográfico inhomogéneo , con fibrosis de la capsula quirurguica. Cápsula conservada.
Jets ureterales visibles.
Aorta abdominal de calibre normal.

Revisión Neumológica

¿En qué consiste la revisión neumológica?

La revisión pulmonar es un proceso médico que tiene como objetivo evaluar la salud y el funcionamiento de los pulmones. Esta revisión se realiza para detectar posibles problemas respiratorios, diagnosticar enfermedades pulmonares y evaluar la función pulmonar. La revisión pulmonar puede involucrar los siguientes procedimientos y pruebas:

Historia clínica, entrevista y examen físico: Durante una revisión neurológica, el neurólogo puede llevar a cabo una serie de procedimientos y pruebas, que pueden incluir:

Pruebas de función pulmonar: Estas pruebas miden la capacidad y eficiencia de los pulmones para respirar y transferir oxígeno al torrente sanguíneo. Algunas de las pruebas más comunes incluyen:

- Espirometría: Mide la capacidad pulmonar, el flujo de aire y la resistencia de las vías respiratorias. Ayuda a diagnosticar enfermedades respiratorias como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

- Radiografía de tórax: La radiografía de tórax es una imagen de rayos X que muestra los pulmones, el corazón, las costillas y las estructuras adyacentes. Puede ayudar a identificar signos de enfermedades pulmonares, como neumonía, tumores, derrames pleurales o enfermedades pulmonares intersticiales.

Juicio Clínico:

ESPIROMETRIA: Valores espirométricos dentro del rango de normalidad.

Revisión de Aparato Digestivo

¿En qué consiste la revisión de Aparato Digestivo?

La revisión del aparato digestivo es un conjunto de procedimientos médicos diseñados para examinar y evaluar la salud y el funcionamiento del sistema digestivo. El objetivo de esta revisión es detectar posibles trastornos digestivos, diagnosticar enfermedades y evaluar el estado general del sistema digestivo.La revisión del aparato digestivo puede implicar los siguientes procedimientos y pruebas:

- Historia clínica y entrevista: El médico realizará una entrevista exhaustiva para obtener información sobre tus síntomas digestivos, antecedentes médicos, historial de enfermedades gastrointestinales previas, estilo de vida y hábitos dietéticos.

- Examen físico: El médico llevará a cabo un examen físico general y específico del abdomen para evaluar cualquier anormalidad, como dolor, sensibilidad, masas o distensión abdominal.

- Análisis de sangre y pruebas de laboratorio: Se pueden realizar análisis de sangre para evaluar los niveles de enzimas hepáticas, marcadores tumorales, función renal y otros parámetros que pueden indicar trastornos digestivos o problemas en el sistema gastrointestinal.

- Endoscopia digestiva alta: Este procedimiento utiliza un endoscopio flexible para examinar el esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado (duodeno). Permite la visualización directa de las estructuras internas y la toma de muestras de tejido para biopsias si es necesario.

- Colonoscopia: Es un procedimiento en el que se utiliza un endoscopio para examinar el colon y el recto. Permite la detección y remoción de pólipos, y la toma de biopsias para evaluar posibles enfermedades, como el cáncer de colon.

Informe de su exploración del aparato digestivo:

INFORME DE COLONOSCOPIA
EXPLORACIÓN:
Preparación: Buena. Boston 2-2-2
Tacto rectal: normal.
Anuscopia: Hemorroides internas grado I-II no complicadas
Exploración: Se explora hasta fondo cecal identificando la válvula ileocecal y el foramen apendicular que son normales. Mucosa y vascularización sin alteraciones en todos los tramos explorados salvo un pequeño pólipo de 5 mm a 40 cm del margen anal que se reseca con pinza.
Procedimientos: Polipectomía
Diagnósticos:
Pequeño pólipo de sigma.

Sanitas

HOSPITAL SANITAS CIMA

Manuel Girona

93 552 27 00